

TEMA 1.11 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Estenosis Carotídea, Disección Carotídea y Vertebral

PERFIL EUNACOM 4.01.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Vascular del Cuello

El adecuado enfrentamiento a la estenosis y al desgarro vascular carotídeo marcan la supervivencia neurológica de la irrigación en el polígono de Willis.

1. Estenosis Carotídea Ateromatosa

- **Etiología:** Principalmente factores de riesgo cardiovascular por placa de ateroma de Colesterol. (Causas infrecuentes: Arteriopatía Displasia Fibromuscular en jóvenes y Arteritis de Takayasu en mujeres jóvenes). - **Clínica:** Frecuentemente asintomática. A la exploración rutinaria asoma un **soplo cervical** proyectado. En su formato catastrófico debutará como isquemia cerebral: **Accidente Isquémico Transitorio (TIA)** o un **ACV isquémico instalado embólico**. - **Diagnóstico:** Eco-Doppler Carotídeo de Cuello. Todo paciente con TIA o ACV embólico debe realizarse de inmediato este estudio buscando la "fuente de émbolos", al igual que ante el hallazgo un soplo carotídeo casual. - **Graduación Terapéutica y de Cirugía:** 1. Si la placa ocluye < 50%: Tratamiento médico de los factores de riesgo cardiovasculares y estatinas. 2. Si la placa ocluye el 50% al 69% con SÍNTOMAS (ha hecho ACV o TIA): **Endarterectomía Carotídea Quirúrgica**. 3. Si la placa ocluye > 70%: Extracción por **Endarterectomía** independientemente de si tiene o carece de síntomas (operación profiláctica obligada).

2. Disección Carotídea y Vertebrobasilar

Resulta de la ruptura intimal y formación de falsa luz en la pared arterial tras un fenómeno traumático de cuello (Ej. "Latigazo" automotriz, maniobras vigorosas osteopáticas o estiramiento cráneo-cervical del deporte extenuante). - **Triada Clínica Clásica:** 1. **Dolor Cervical:** Dolor directo y agudo lateral ipsilateral vascular. 2. **Cefalea Súbita:** Fuerte, intensa tipo "trueno" (*Thunderclap headache*). Se debe hacer diagnóstico diferencial con Hemorragia Subaracnoidea. 3. **Síntomas de ACV inminente:** El vaso taponado con el cuajo falso desencadena isquemias colaterales rápidas. - **Disección Carotídea:** Infartos correspondientes al territorio de la Arteria Cerebral Media (ACM) o Cerebral Anterior (ACA). - **Disección Vertebrobasilar:** Infarto del territorio posterior; comprometiendo tronco encefálico o manifestando síndrome isquémico del cerebelo (mareos masivos, nistagmus disociativo atáxico). - **Diagnóstico confirmatorio: Angio-TAC o Angio-RMN de Vasos Cervicales.** El Angio-TAC tiene inmensa rapidez en contexto

de urgencia oclusiva. - **Tratamiento:** Se instaura contraintuitivamente una rotunda **Anticoagulación plémica (Heparina)** para evitar perpetuar e impactar la avalancha del falso trombo contra la luz del cerebro, previniendo los émbolos masivos originados por el flujo laminar caótico del falso lumen. Eventual revascularización quirúrgica se aplica si la isquemia es extrema y total o la anticoagulación no resuelve o flaquea el riesgo isquémico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un hombre de sesenta años con hipertensión arterial y dislipidemia presenta un soplo cervical al examen físico. No refiere síntomas neurológicos. ¿Cuál es el examen indicado y cuándo se opera?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Estenosis Carotídea, Disección Carotídea y Vertebral. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La estenosis carotídea es asintomática o se presenta con accidente isquémico transitorio o accidente vascular encefálico; el diagnóstico es con ecodoppler de carótidas.
- El ecodoppler de carótidas es obligatorio ante todo accidente isquémico transitorio o accidente vascular encefálico de origen embólico y ante soplo cervical.
- Las indicaciones de endarterectomía carotídea son estenosis mayor al setenta por ciento, o estenosis mayor al cincuenta por ciento con accidente isquémico transitorio o accidente vascular encefálico.
- La disección carotídea o vertebral ocurre tras ejercicios de elongación del cuello y presenta tríada de dolor cervical, cefalea en trueno y déficit neurológico isquémico.
- La disección carotídea afecta la arteria cerebral media o anterior; la vertebral afecta la arteria cerebral posterior, el tronco encefálico o el cerebelo.
- El diagnóstico de disección carotídea o vertebral se confirma con angiotac o angiorresonancia que dibuja el árbol arterial.
- El tratamiento de la disección carotídea y vertebral es anticoagulación con heparina, a diferencia de la disección aórtica donde está contraindicada.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESTENOSIS CAROTÍDEA, DISECCIÓN CAROTÍDEA Y VERTEBRAL)**PREGUNTA 1**

Un hombre de sesenta años con hipertensión arterial y dislipidemia presenta un soplo cervical al examen físico. No refiere síntomas neurológicos. ¿Cuál es el examen indicado y cuándo se opera?

- A)** No se estudia si no tiene síntomas neurológicos
- B)** Ecodoppler de carótidas; se opera si la estenosis es mayor al setenta por ciento
- C)** Angiotac de carótidas; se opera si la estenosis es mayor al cincuenta por ciento
- D)** Ecodoppler de carótidas; se opera solo si tiene síntomas neurológicos
- E)** Resonancia magnética de cerebro; tratamiento solo con estatinas

PREGUNTA 2

Una mujer de treinta y cinco años presenta cefalea de inicio súbito, dolor cervical y hemiparesia derecha luego de una clase de yoga con movimientos de estiramiento cervical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A)** Hemorragia subaracnoidea; angiografía urgente
- B)** Disección carotídea; anticoagulación con heparina
- C)** Accidente vascular encefálico cardioembólico; aspirina
- D)** Estenosis carotídea ateromatosa; endarterectomía urgente
- E)** Migraña con aura; analgésicos y reposo

PREGUNTA 3

Un paciente de setenta años tuvo un accidente isquémico transitorio hace una semana. El ecodoppler de carótidas muestra estenosis del cincuenta y cinco por ciento en la carótida interna derecha. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Observación y control en seis meses
- B)** Tratamiento médico con estatinas y antiagregantes solamente
- C)** Endarterectomía carotídea
- D)** Esperar hasta que la estenosis supere el setenta por ciento para operar
- E)** Angiotac de carótidas para confirmar antes de decidir

RESUMEN: ESTENOSIS CAROTÍDEA, DISECCIÓN CAROTÍDEA Y VERTEBRAL

La estenosis carotídea puede ser asintomática, manifestándose solo con un soplo cervical, o bien sintomática con un accidente isquémico transitorio o un accidente vascular encefálico. La causa más frecuente es la ateromatosis por factores de riesgo cardiovascular, aunque también existe la displasia fibromuscular en jóvenes y la arteritis de Takayasu en mujeres jóvenes. El diagnóstico se hace con el ecodoppler de carótidas, que es obligatorio pedir ante todo accidente isquémico transitorio o accidente vascular encefálico de origen embólico, así como ante un soplo cervical. Se considera estenosis cuando supera el cincuenta por ciento del lumen. El tratamiento depende del grado de estenosis y los síntomas. Las indicaciones de cirugía mediante endarterectomía carotídea son dos: estenosis mayor al setenta por ciento sin importar los síntomas, y estenosis mayor al cincuenta por ciento en pacientes sintomáticos con accidente isquémico transitorio o accidente vascular encefálico. En los casos sin indicación quirúrgica, el tratamiento es médico con control de factores de riesgo cardiovascular. La disección carotídea y vertebral se produce tras ejercicios de elongación o movimientos bruscos del cuello. Clínicamente presenta la tríada de dolor cervical, cefalea en trueno de inicio súbito y síntomas de accidente vascular encefálico. Si es de la carótida, afecta la arteria cerebral media o anterior; si es vertebral, afecta la arteria cerebral posterior, tronco encefálico o cerebelo. El diagnóstico se confirma con angiotac o angiorresonancia. El tratamiento es anticoagulación con heparina, a diferencia de la disección aórtica donde está contraindicada. Si hay obstrucción severa, se requiere cirugía.